

학교 현장 호발 감염병 10종 신속 대응 가이드

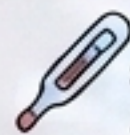
원인부터 등교 중지 기준까지, 한눈에 파악하는 인포그래픽 매뉴얼

Respiratory



1. 인플루엔자 (Influenza)

원인: 인플루엔자 바이러스 (비말/접촉)



등교 중지 (●)

해열제 없이 정상 체온 회복
후 24시간 경과 시까지

Respiratory



2. 마이코플라스마 폐렴 (Mycoplasma Pneumonia)

원인: 마이코플라스마 폐렴균 (비말/접촉)

등교 중지 (●)

증상 완화 및 해열 후 등교 가능
(치료 후에도 기침 장기간 지속 가능)

Respiratory



3. 백일해 (Pertussis)

원인: 백일해균 (비말/접촉)



등교 중지 (●)

합병제 적용 5일 후까지
(이득용 시 3주)

Skin/Rash



4. 수두 (Chickenpox)

원인: 수두 대상포진 바이러스 (비말/접촉)



등교 중지 (●)

모든 수포가 막지가
될 때까지

Skin/Rash



5. 유행성이하선염 (Mumps)

원인: 임프스 바이러스 (비말/접촉)



등교 중지 (●)

증상 발현 후
5일까지

Skin/Rash



6. 성홍열 (Scarlet Fever)

원인: A군 연쇄상구균 (비말/접촉)



등교 중지 (●)

한번에 붉은
24시간 후까지

Skin/Rash



7. 수족구병 (Hand, Foot, and Mouth Disease)

원인: 콕사키바이러스 등 (접촉/비말)



등교 중지 (●)

열이 내리고 입안
물집이 나올 때까지

Gastrointestinal



8. 노로바이러스 감염증 (Norovirus Infection)

원인: 노로바이러스
(오염된 음식/물/접촉)



등교 중지 (●)

증상 소실 후
48시간까지

Eye/Other



9. 유행성각결막염 (Epidemic Keratoconjunctivitis)

원인: 아데노바이러스 (접촉)



등교 중지 (●)

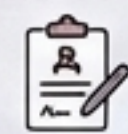
격리증이 개인위생 수칙을
철저히 지킬 것을 권장

Respiratory



10. 결핵 (Tuberculosis)

원인: 결핵균 (비말, 공기)



등교 중지 (●)

치료 시작 후 전염력이
없을 때까지
(의사 소견에 따름)

인플루엔자 (Influenza)

❄ 겨울~초봄(12~3월)

🌸 학령기 2차 유행

🚨 제4급 법정감염병

원인 및 주요 증상

인플루엔자바이러스

(비말·접촉감염, 잠복기 1~4일)



두통



인후통



근육통

등교 중지 기준

24시간

해열제 없이 정상 체온 회복 후
24시간 경과 시까지

(해열제 투약 시 마지막 투약 후 48시간)

현장 대응 포인트

- ☑ 질병관리청 의사환자분율(ILI) 매주 확인하여 유행 조기 파악
- ☑ 발열 학생 조기 귀가 조치 및 마스크 착용 안내

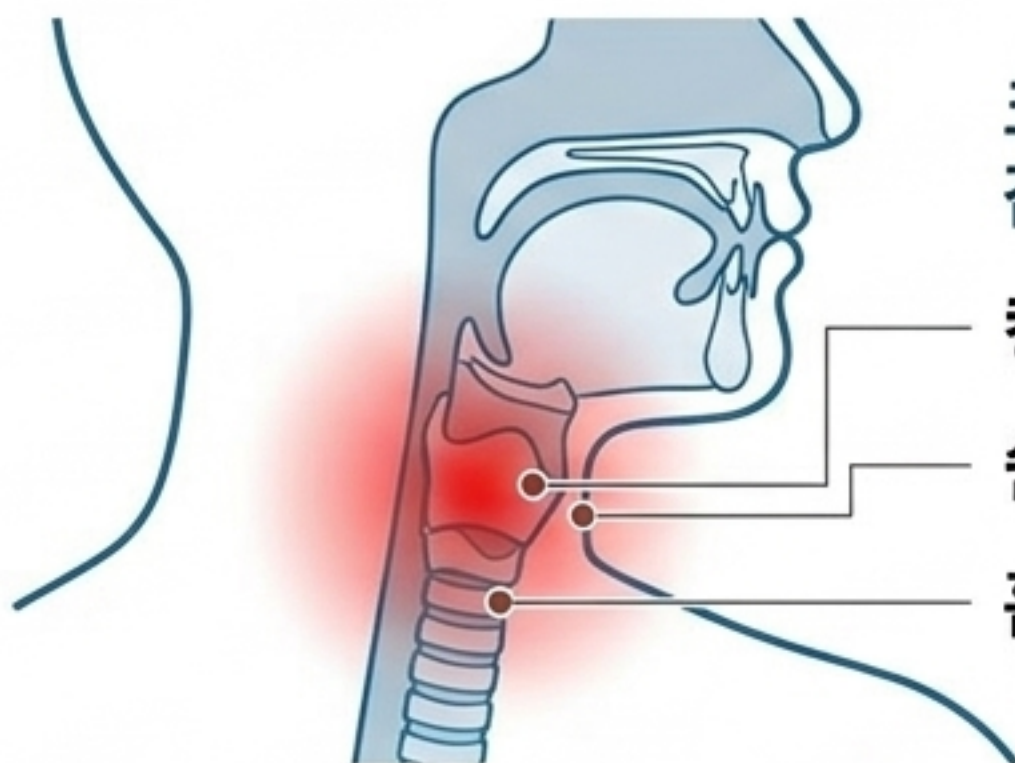
급성호흡기감염증 - 바이러스성

🔄 사계절 상시 (여름철 주의)

🚨 제4급 법정감염병

원인 및 주요 증상

파라인플루엔자, 리노바이러스 등
(비말·접촉감염)



크룹(Croup)
감별 포인트

컹컹거리는 기침

쉰 목소리

흡기성 천명

등교 중지 기준



증상 중심 판단

(발열 동반 시 인플루엔자에 준하여
해열 후 24시간 격리 안내)

현장 대응 포인트

- ☑️ 독감과 혼동 주의
- ☑️ '컹컹 기침 + 숨소리 이상' 시 크룹(후두염) 의심
및 즉시 진료 권고
- ☑️ 특정 백신·치료제가 없어 손씻기/기침 예절 등
방역수칙 반복 안내

급성호흡기감염증 - 세균성 (마이코플라스마)

❄️ 최근 겨울철 대유행

🚨 제4급 법정감염병

원인 및 주요 증상

마이코플라스마 폐렴균
(밀집 환경 전파)



잠복기: 2~3주

2주 이상 지속되는 기침



등교 중지 기준



법정 의무는 없으나, 호흡기
증상이 있는 동안 등교 자제 권고
(미등원 시 법정감염병 결석 인정)

현장 대응 포인트

- ☑️ 잠복기가 길어 학급 내 수주간 유행 가능
(초기 통제 중요)
- ☑️ 기침 2주 이상 지속 학생은 조기 진료 권고
- ☑️ 입원환자 주간 250명 이상 시 질병관리청
유행주의보 확인

백일해 (Pertussis)

❁ 봄~초여름 확산

🎒 학령기(7~19세) 집중

🚨 제2급 법정감염병

임상 경과 3단계



등교 중지 기준

항생제 복용 시: 5일

미치료 시: 3주

유효 항생제 복용 시작 후 5일 경과 시까지 격리
(미치료 시 기침 발작 후 3주간)

현장 대응 포인트

- ☑️ 교직원(임신부/영아 접촉자) Tdap 접종력 확인
- ☑️ 초기(카타르기)에 감기와 구분이 어려우므로
학급 내 지속 기침자 유의 모니터링

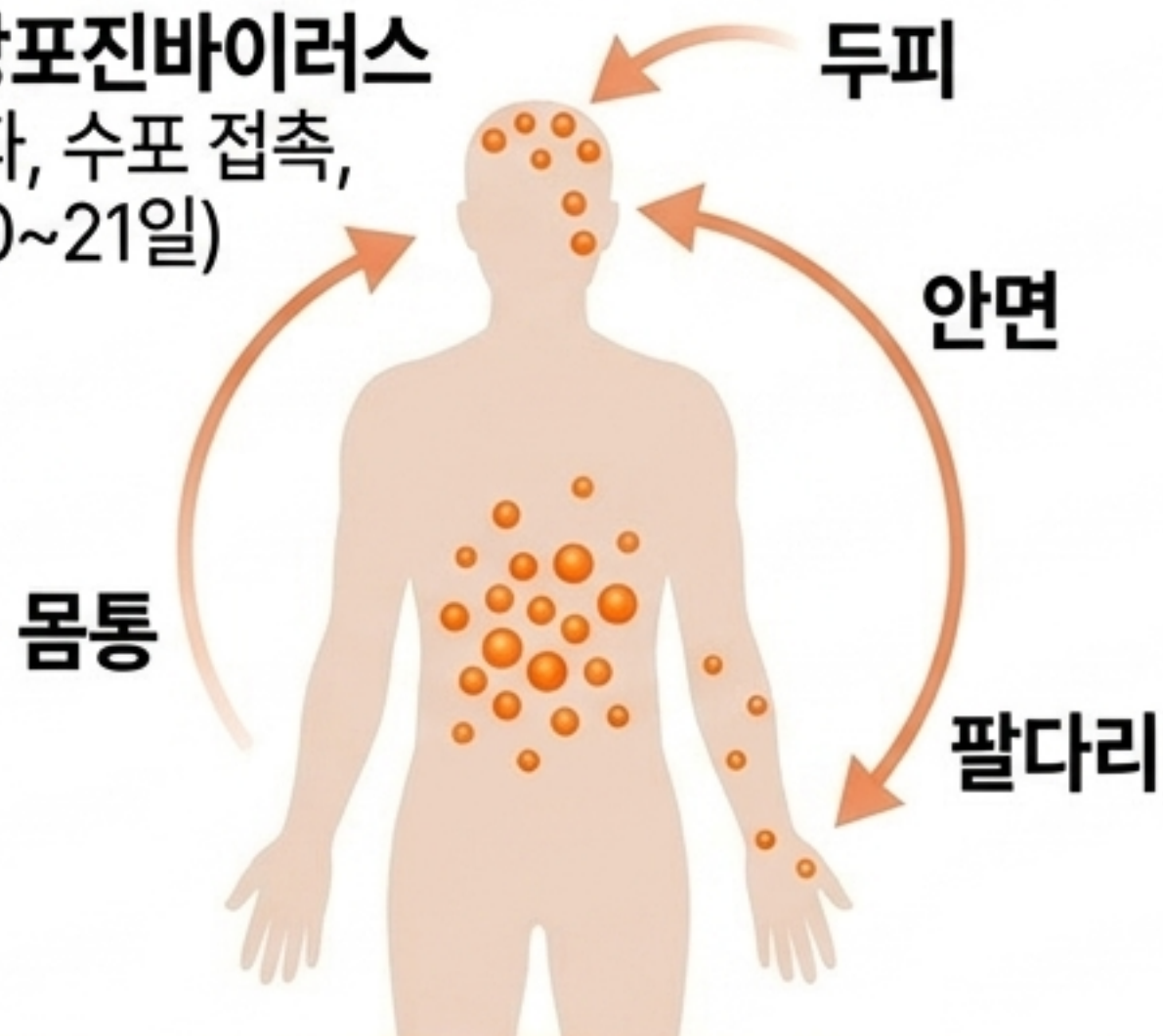
수두 (Varicella / Chickenpox)

❁ 봄철(4~6월) 집중 유행

🚨 제2급 법정감염병

원인 및 발진 진행 경로

수두대상포진바이러스
(공기 전파, 수포 접촉,
잠복기 10~21일)



등교 중지 기준



모든 피부 병변에 가피(딱지)가
형성될 때까지
(발진 발생 후 최소 5일)

현장 대응 포인트

- ☑ 잠복기 중 무증상 전파 유의
- ☑ 접촉력 없는 학생 파악 및 수포성 발진 학생 즉시 격리 안내

유행성이하선염 / 볼거리 (Mumps)

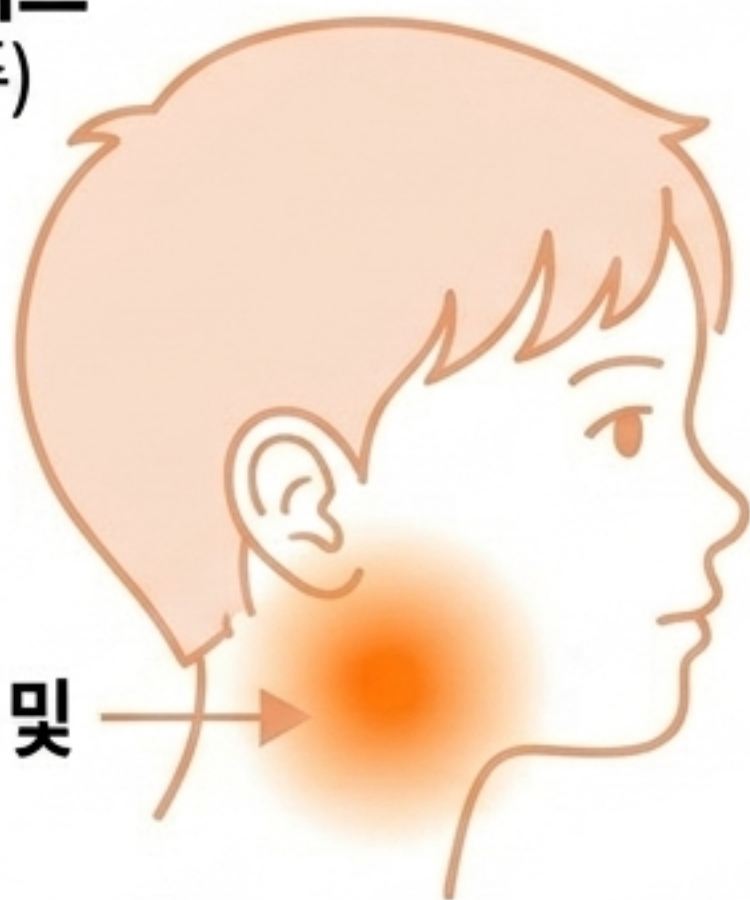
🌸 봄철(4~6월)

🎒 5~15세 다발

🚨 제2급 법정감염병

원인 및 주요 증상

유행성이하선염바이러스
(비말감염, 잠복기 2~3주)



귀밑 침샘(이하선) 부종 및
씹거나 삼킬 때 통증

등교 중지 기준



이하선염 증상 발생 후
5일까지 등교 중지

현장 대응 포인트

- ☑ 가벼운 침샘염과 혼동해 등교하는 사례 주의
- ☑ 역학적 연관성이 강하게 의심되면 즉시 진단검사 권고

성홍열 (Scarlet Fever)

[❄️ 늦겨울~초봄]

🎒 6~12세 다발

🏠 제2급 법정감염병

3대 주요 증상

A군 베타용혈성연쇄구균
(비말·접촉감염)



갑작스런
고열/인후통



선홍색
미만성 발진



딸기혀
(Strawberry Tongue)

등교 중지 기준



항생제 치료 시작 후
24시간까지 자택 격리

현장 대응 포인트

- ☑ 동일 학급 7일 이내 2명 이상 발생 시 '유행'으로 특별 관리
- ☑ 치료 시작 24시간 후 등교가 가능하므로, 진단서상 '치료 시작일' 정확히 확인

수족구병 (Hand, Foot and Mouth Disease)

☀ 여름철(6~9월)

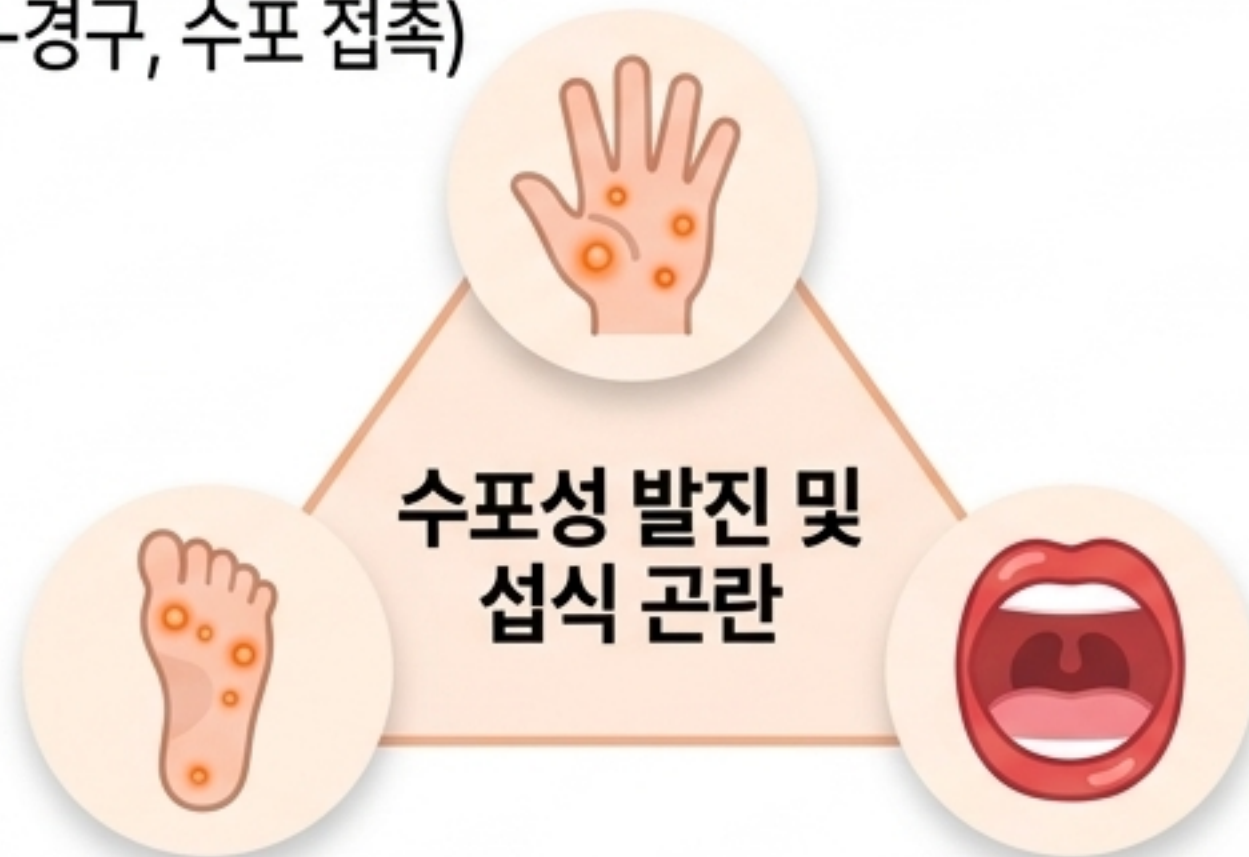
🎒 영유아·초등 저학년 다발

⚠ 표본감시 대상

원인 및 주요 증상

장바이러스

(분변-경구, 수포 접촉)



등교 중지 기준



수포 발생 후 6일간 또는 모든
병변에 가피가 형성될 때까지 권고

현장 대응 포인트

- ☑ 유치원(병설) 및 초등 저학년 담임과 위생관리 협업 필수
- ☑ 장난감, 집기 소독 및 급식 전후 위생관리 연계 강조

노로바이러스 감염증 (Norovirus Infection)

❄ 겨울철(11~2월) 집단발생 다발

🚑 제2급 법정감염병

원인 및 주요 증상

노로바이러스

(구토물 비말, 오염된 식품·물, 잠복기 12~48시간)



급성 구토,
설사, 복통

등교 중지 기준

🕒
48시간

구토·설사 증상이 완전히 사라진 후
48시간이 경과할 때까지

현장 대응 포인트



염소계 소독제

- ☑ 급식실 연계 위생관리가 최우선 과제
- ☑ 구토물 처리 프로토콜 사전 점검
(반드시 염소계 소독제 사용, 환자 즉시 격리)

유행성각결막염 / 눈병 (Epidemic Keratoconjunctivitis)

🎒 학기 초·여름철 다발

⚠️ 비법정감염병 (격리 권고)

원인 및 주요 증상

아데노바이러스

(눈 분비물 직접·간접 접촉, 수건 등 공유)



• 충혈, 눈곱, 이물감, 눈물
(한쪽 눈에서 양쪽으로 번짐)

등교 중지 기준



강제 격리 없이 개인위생 수칙
철저 준수 권장 (단, 감염력이 강함)

현장 대응 포인트

- ☑ 개인 수건 사용, 눈 만지지 않기 교육 필수
- ☑ 법정감염병이 아니므로 등교 중지를 둘러싼 학부모 이견 방지를 위해 '안내 문구 사전 표준화'

결핵 (Tuberculosis)



연중 발생 가능 (장기 치료 필요)



제2급 법정감염병 (격리 치료)

원인 및 주요 증상

결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*) 감염
(공기 중 비말핵 전파)



- 2주 이상 지속되는 기침, 가래(객담), 혈담, 호흡곤란, 흉통
- 발열, 야간 발한(식은땀), 식욕 부진, 체중 감소, 쇠약감
- (폐외 결핵 시) 발병 부위에 따라 림프절 부종, 척추 통증 등 다양한 증상

등교 중지 기준

결핵 치료 시작 후 보통 2주 이상
(담당 의사 확인 후 복귀 가능)

현장 대응 포인트

- ☑ 진단 초기 즉시 등교·출근 중지
- ☑ 표준 치료(6~9개월) 및 복약
순응도 관리(약제 내성 방지)
- ☑ 접촉자 관리(보건소 협조), 절대 금주·금연,
고단백 영양 섭취 및 BCG 백신 접종 권장



학교 호발 감염병 등교 중지 & 대응 매트릭스

질환별 복귀 기준 마스터 시트 (Master Action Matrix)

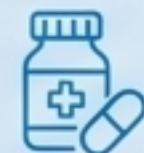
증상 소실 후 시간 기준



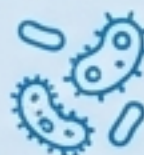
 인플루엔자 : 해열 후 **24시간** (투약 시 **48시간**)

 노로바이러스 : 구토/설사 소실 후 **48시간** 

치료 시작 기준



성홍열 : 항생제 치료 시작 후 **24시간**



백일해 : 항생제 복용 시작 후 **5일**



가피(딱지) 형성 기준



수두 : 모든 병변 딱지 형성 (최소 **5일**)



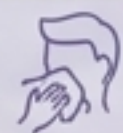
수족구병 : 딱지 형성 (또는 **6일간**)



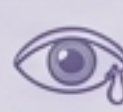
증상 중심 / 비격리 중심



유행성이하선염(볼거리) : 증상 발생 후 **5일**



급성호흡기감염증 : 증상 시 등교 자제 권고



유행성각결막염 / 머릿니 : 등교 가능 (위생 철저)

